

Université Constantine 3 -département de médecine

Faculté de médecine

Syndrome hépatitiques

Cours de Sémiologie digestive : étudiants de 3ème année médecine

Année 2024/2025

Préparé par : Dr Kermiche.M

Maître assistante en médecine interne CHU Constantine

Objectifs :

1. Reconnaître un syndrome hépatitique clinique et biologique
2. Reconnaître une hépatite chronique
3. Citer les principales méthodes d'évaluation de la fibrose
4. Enumérer les principales étiologies des hépatites

Plan du cours:

- I. Introduction/Définition
- II. Physiopathologie
- III. Diagnostic positif
- IV. Bilan biologique
- V. Examens paracliniques
- VI. Etiologies

Syndrome hépatiques

1. INTRODUCTION/DEFINITION :

Le syndrome hépatique est l'ensemble de manifestations cliniques et biologiques d'une hépatite

L'hépatite est définie comme une inflammation du foie qui peut résulter de diverses causes

La cause la plus fréquente d'hépatite est une infection virale

L'hépatite peut être classée en aiguë et chronique selon la durée de l'inflammation

- moins de six mois : aiguë

- plus de six mois : chronique

L'hépatite aiguë est généralement résolutive, mais peut entraîner une insuffisance hépatique fulminante

L'hépatite chronique peut provoquer des lésions hépatiques, notamment fibrose, cirrhose et ces complications

Hépatopathie : maladie (détérioration des fonctions) du foie

Cirrhose : maladie irréversible et diffuse du foie caractérisée par une fibrose hépatique diffuse, entraînant une destruction des cellules hépatiques et une régénération anarchique sous forme de nodules.

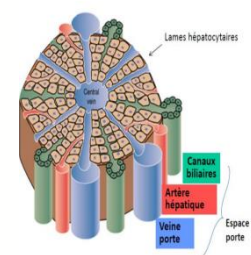
correspondant à l'évolution ultime de la plupart des maladies chroniques du foie.

Insuffisance hépatique fulminante : syndrome résultant d'une altération massive et brutale des fonctions hépatiques, entraînant des conséquences extrahépatiques, les plus sévères étant l'encéphalopathie hépatique et la défaillance multiviscérale

L'encéphalopathie hépatique l'ensemble des troubles neurologiques ou neuropsychiatriques associés à une atteinte du foie (due à l'accumulation de toxines dans le cerveau)

2. PHYSIOPATHOLOGIE :

- Multiples fonctions
 - Synthèse de la **bile** : permet l'émulsion des lipides et donc leur absorption (détergent)
 - Nutritionnelle :
 - Importance dans le métabolisme des lipides
 - Importance dans le métabolisme des glucides : synthèse et utilisation du glycogène
 - Absorption des vitamines liposolubles (A,D,E,K)
 - Synthèse de la plupart des **protéines sanguines**
 - **Albumine**, facteurs de coagulation
 - **Détoxification**, transformation de certains médicaments : adapter la posologie en cas de problème hépatique



DIAGNOSTIC POSITIF

3. **EXAMEN CLINIQUE:**

---Interrogatoire :

- Sexe, âge, et état général
- Une prise médicamenteuse (ex : paracétamol). Tout médicament suspect devra être arrêté ou l'exposition à un toxique, Consommation d'alcool
- Des facteurs de risques de contagie viral (voyage en zone d'endémie, toxicomanie intraveineuse, relation sexuelle non protégée, travail dans le domaine de la santé).
- Antécédents familiaux d'hépatite.
- Antécédents personnels : de maladies auto-immunes, maladie du foie
- Fréquence, durée et évolution des symptômes

---Signes fonctionnels :

- Fatigue: Une sensation de fatigue chronique ou d'épuisement général.
- Douleurs abdominales: Douleurs dans la partie supérieure droite de l'abdomen, parfois accompagnées de malaise.
- Perte d'appétit: Une perte de goût pour la nourriture et une sensation de satiété rapide.
- Nausées et vomissements
- Altérations de l'état général: dépression, perte de poids, Syndrome grippal, arthralgies, fièvre ...

---Inspection:

Ictère: Jaunissement de la peau et du blanc des yeux, dû à l'accumulation de bilirubine.
Urine foncée: La couleur de l'urine devient plus foncée en raison de la bilirubine excrétée
Selles pâles: Les selles peuvent prendre une couleur blanchâtre ou argileuse en raison de l'insuffisance de bile.
Démangeaisons: Une sensation de démangeaison cutanée intense, difficile à soulager.

---Palpation: Hépatomégalie: Augmentation de volume du foie :

- diffuse ou localisé
- mobile avec la respiration
- surface: régulière /irrégulière
- sensible ou indolore
- bord inférieur :tranchant/épais/mince/régulier ou non
- consistance: molle/ferme/dur

Ascite: Accumulation de liquide dans l'abdomen

--- Tableaux cliniques spécifiques :

Insuffisance hépatique aiguë (hépatite fulminante) :

Les principales manifestations cliniques sont l'encéphalopathie et l'ictère et biologiques : pic d'activité de l'alanine transaminase, troubles de coagulation et hypoglycémie

Encéphalopathie hépatique :

Critères diagnostiques de l'encéphalopathie hépatique :

1. Signes neuropsychiatriques :

1. Troubles cognitifs (désorientation, confusion).
2. Altérations du comportement (irritabilité, léthargie).
3. Troubles moteurs (tremblements, astérisis ou *flapping*).

2. Anomalies électroencéphalographiques (EEG) :

1. Ralentissement des ondes.
2. Apparition de rythmes triphasiques dans les cas avancés.

3. Contexte clinique :

1. Maladie hépatique chronique (ex. : cirrhose).
2. Absence d'autres causes pouvant expliquer les symptômes neuropsychiatriques.

Facteurs déclenchants potentiels:

- Infections (péritonite bactérienne spontanée, septicémie)
 - Saignements digestifs
- Désordres électrolytiques (hyponatrémie, hypokaliémie)
- Prise excessive de protéines alimentaires
 - Constipation
- Médicaments sédatifs.

Échelle de West Haven

Grade	Description clinique
0	Aucun signe clinique détectable, mais des tests neuropsychométriques ou neurophysiologiques sont anormaux.
1	Légers troubles cognitifs, confusion subtile, insomnie, irritabilité, astérisis souvent absent.
2	Léthargie, désorientation temporelle, astérisis présent.
3	Confusion sévère, désorientation majeure, somnolence marquée, mais réponse aux stimuli verbaux.
4	Coma profond, aucune réponse aux stimuli verbaux, seulement des réponses motrices réflexes.

Asterixis ou *flapping tremor*, chute brutale et de brève durée du tonus musculaire des extenseurs de la main (mouvements involontaires et rythmiques des poignets et des doigts)
Léthargie : État pathologique de sommeil profond et prolongé

En cas de cirrhose (stade évolutif des hépatites chroniques et toutes hépatopathies) :

- Signes d'insuffisance hépatique chronique
- Hypertension portale
- Parfois aucun signe (quand la cirrhose est compensée)

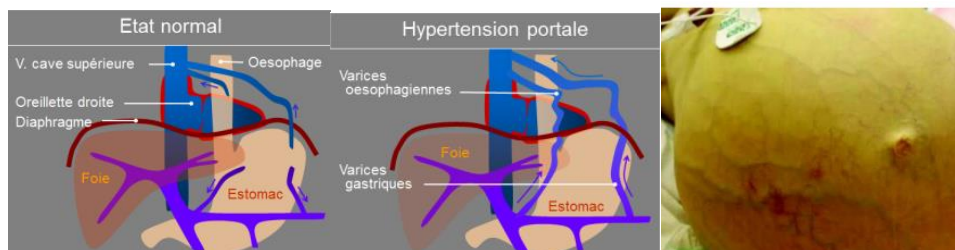
Signes d'insuffisance hépatique chronique :

- Hippocratisme digital : ongles en verre de montre.(non spécifique de l'insuffisance hépatocellulaire)
- Erythrose palmaire : ongles blancs, cassants, striés.
- Angiomes stellaires : formation vasculaire avec un petit point au centre avec une forme d'étoile autour. Ces lésions s'effacent à la vitro-pressions
- Encéphalopathie hépatique



Signes d'Hypertension portale :une augmentation de la pression sanguine dans le système de la veine du système porte

- Ascite
- Splénomégalie.
- Circulation veineuse collatérale ou dérivations porto-cave (ou porto-systémiques):
- Hémorragies (hypersplénisme suite a une thrombopénie , hémorragie digestives par ruptures de varices œsophagiennes et/ou gastriques



BILAN BIOLOGIQUE:

Les tests biochimiques tels que l'ASAT, l'ALAT, la phosphatase alcaline, la GGT, la lactate déshydrogénase, la bilirubine, le TP/INR et l'albumine permettent de déterminer le fonctionnement normal du foie.

- L'élévation des transaminases (habituellement très élevé (> 10 fois la normale : l'hépatite aiguë)
- L'élévation des taux de phosphatase alcaline (PA) et de gamma-glutamyl transférase (GGT) reflète une cholestase sous-jacente secondaire à une altération de la sécrétion biliaire du foie
- Baisse de fonction synthétique : TP, Albumine, hypoglycémie
- La recherche de l'étiologie: bilan sérologique simple : IgM anti-VHA, antigène HBs, anticorps anti VHC...bilan d'autoimmunité, bilan méabolique...

Examens paracliniques :

- *L'échographie*: indispensable. Elle étudie :
 - le foie (taille, forme, échogénicité, homogénéité),
 - le(s) nodule(s) (liquidité, échogénicité, forme, homogénéité, nombre et situation précise, vascularisation en s'aidant si besoin de l'injection de produit de contraste),
 - les veines (sus)hépatiques, la veine cave inférieure, la veine porte et ses branches, les voies biliaires,
 - recherche de l'ascite, la rate, et recherche d'autres

anomalies intra-abdominales (tumeurs essentiellement).

Les principaux méthodes d'évaluation de la fibrose :

L'évaluation de la fibrose hépatique a deux objectifs cliniques distincts :

- déterminer la sévérité des lésions hépatiques à un instant précis de l'évolution
- évaluer périodiquement l'évolution de la sévérité des lésions au cours du suivi du patient

- Marqueurs sériques et score de fibrose

Les inconvénients de la biopsie hépatique ont conduit de nombreuses équipes à évaluer la fibrose à l'aide d'outils moins invasifs.

Des scores calculés qui combinent plusieurs variables ont donc été développés afin d'améliorer les performances de ces tests pour l'estimation de la fibrose.

Le Fibrotest®

qui correspond à un indice de fibrose, déterminé à partir du dosage

sanguin de 5 marqueurs indirects de fibrose hépatique :alpha-2-macroglobuline, haptoglobine, apolipoprotéine A1, bilirubine totale, gamma-GT) et d'un ajustement à l'âge et au sexe du patient.

Le FIB4 :

test de dépistage de la fibrose hépatique, calculé à partir de la numération plaquettaire, de l'âge du patient et des transaminases, disponible sur internet et gratuit.

Un index FIB-4 < 1,45 élimine le diagnostic de cirrhose avec une valeur prédictive négative de 90 % ; un index FIB-4 > 3,25 est en faveur de ce diagnostic (valeur prédictive positive de 65 %).

Les maladies du foie sont fréquentes, latentes et parfois difficiles à diagnostiquer. Une évaluation systématique améliore la survie ; de fait, le FIB-4 devrait faire partie du bilan hépatique systématique, en particulier des patients à risque.

Le Fibroscan ou élastométrie

-Totalemment indolore et rapide (quelques minutes). Le résultat immédiate. peut être renouvelé aussi souvent que nécessaire

Est une approche non invasive capable d'évaluer la fibrose hépatique, en mesurant le degré d'élasticité du foie grâce à une sonde d'échographie spécifiquement adaptée

L'élasticité du foie est mesurée en kilopascal (kPa). La valeur obtenue correspond à la médiane de 10 mesures, différents stades sont décrits :

- ☐ entre 2,5 et 7, on parle de stade F0 ou F1 : absence de fibrose ou fibrose minime
- ☐ entre 7 et 9,5, on parle de stade F2 : fibrose modérée
- ☐ entre 9,5 et 14, on parle de stade F3 : fibrose sévère
- ☐ au-delà de 14, on parle de stade F4 : du tissu cicatriciel est présent dans tout le foie, et une cirrhose est présente

La ponction-biopsie hépatique

Réalisé par voie transpariétale ou transjugulaire.Examen invasive; apres avoir éliminer les contre-indications (troubles de coagulation, anomalies des voies biliaires, ascite)

Le test a pour but :

- ☐ D'évaluer le degré de sévérité de la fibrose hépatique,
- ☐ De rechercher la cause de l'hépatopathie et/ou d'évaluer d'autres causes éventuelles d'hépatopathie associée

ETIOLOGIES:

Virus spécifiques de l'hépatite :

Les virus de l'hépatite sont la cause la plus courante dans le monde, Il existe cinq types de virus de l'hépatite (désignés par les lettres A, B, C, D et E), mais il existe d'autres virus comme Herpes Simplex, Cytomégalo virus, Epstein- Barr, Adénovirus, Coxsackie

virus	Transmission	Passage à la chronicité
Hépatite A	Fécale-orale	0 %
Hépatite B	Sanguine, sexuelle, mère-enfant	Adultes 5 % Nouveaux-nés 90 %
Hépatite C	Sanguine	85 %
Hépatite D	Comme hépatite B Infection hépatite B nécessaire	
Hépatite E	Fécale-orale	0 %
Hépatite G	Sanguine	80

Autres infections: Infections parasitaires, infections à pyogènes, etc., qui peuvent toucher le foie

Consommation d'alcool :

La maladie hépatique alcoolique est due à l'abus d'alcool pendant une période prolongée. En règle générale, la quantité d'alcool consommée (volume, fréquence et durée) détermine le risque et la gravité des lésions hépatiques.

Elle peut être asymptomatique ou accompagnée de symptômes (peut provoquer trois types de lésions hépatiques) :

Accumulation de graisses (stéatose hépatique),

Inflammation (hépatite alcoolique),

Cirrhose.

Le diagnostic d'hépatite alcoolique est avant tout histologique

Les perturbations biologiques sont peu importantes et ne sont pas spécifiques de l'hépatite alcoolique. On peut citer : cytolysse modérée prédominant sur les ASAT, macrocytose, élévation des γ -GT, etc

Stéatohépatite non alcoolique (Nonalcoholic steatohepatitis, actuellement on parle de : Maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD)):

Une stéatose hépatique correspond à une accumulation de graisse dans le foie, d'où son autre nom, "la maladie du foie gras".

Précisément, la stéatose est une infiltration de triglycérides dans les cellules

□

On parle de stéatose simple quand les cellules hépatiques ne sont pas endommagées : il s'agit d'un stade bénin caractérisé par une accumulation de graisse dans le foie.

□ On parle de stéatose diffuse, ou sévère, lorsqu'on atteint un stade avancé de la pathologie, où l'ensemble du tissu hépatique est touché

Médicaments- toxiques

Les hépatites toxiques ou médicamenteuses sont des hépatites induites par l'ingestion de certaines substances médicamenteuses ou non. Ces dernières provoquent une destruction du foie pouvant être très importante.

C'est le cas de l'amanite phalloïde (champignon vénéneux). Il s'agira dans le cas de certains médicaments hépatotoxiques, comme le paracétamol, apparaissent peu après la prise du médicament et dépendent de la dose administrée

Maladies auto-immunes

L'hépatite auto-immune se définit comme une maladie inflammatoire chronique du foie de cause inconnue, pouvant survenir à tout âge. L'hépatite auto-immune a tendance à évoluer par poussées successives d'intensité variable, entrecoupées de périodes de rémission.
autres maladies auto-immunes : lupus ; polyarthrite rhumatoïde ; maladie cœliaque ;....

Autres :

- Certaines maladies de surcharge métaboliques héréditaires : hémochromatose, maladie de Wilson, déficit en alpha 1 anti trypsine ...
- Maladies vasculaires
- Les granulomatoses tel la sarcoidose
- Pathologies hépatiques gestationnelles